

При туберкулезе ставят аллергическую пробу: {

- ~Шика
 - ~Дика
 - =Манту
 - ~Бюрне
 - ~Френкеля
- }

Для выявления специфической сенсибилизации при туберкулезе ставят кожную аллергическую пробу: {

- ~Митсуда
 - ~Бюрне
 - =Манту
 - ~Френкеля
 - ~Шика
- }

К противотуберкулезным антибиотикам относятся: {

- ~тетрациклин
 - ~пенициллин
 - ~нистатин
 - =рифампицин
 - ~фурациллин
- }

Возбудитель туберкулеза красится по методу: {

- ~Грама
 - ~Нейссера
 - =Циля - Нильсена
 - ~Ожешко
 - ~Романовского – Гимзе
- }

Для выделения туберкулезных микобактерий применяют среды: {

- ~агар Мак-Конки
 - ~КУА
 - ~Борде - Жангу
 - =Левенштейна - Йенсена
 - ~Клауберга
- }

Кислотоустойчивость возбудителя туберкулеза обеспечивают: {

- ~капсула
- ~полисахариды
- =липиды
- ~белковые компоненты
- ~жгутики
- }

Для аллергической диагностики туберкулеза применяют пробу: {

- ~Шика
- ~Дика
- ~Бюрне
- =Манту
- ~Френкеля
- }

Ускоренные методы бактериологической диагностики туберкулеза: {

- ~гомогенизации
- ~флотации
- ~бактериоскопический
- =микрокультур по Прайсу
- ~аллергический
- }

Микобактерии туберкулеза: {

- ~споровые грам (-) палочки
- =окрашиваются по цию - нильсену в красный цвет
- ~имеют жгутики
- ~имеют зерна волютина
- ~образуют капсулу
- }

Микобактерии туберкулеза на плотных средах дают рост: {

- ~через 16-18 ч
- ~через сутки
- ~через неделю
- =через 2-4 недели
- ~через 6 месяцев
- }

Для бактериоскопической диагностики туберкулеза применяют: {

- =микроскопию препаратов, окрашенных по цию-нильсену
- ~микроскопию препаратов, окрашенных по граму
- ~метод висячей капли
- ~фазово-контрастную микроскопию
- ~микроскопию в «темном поле»

}

Иммунитет при туберкулезе: {

~кратковременный

=нестерильный

~выявляется в реакции шика

~антивирусный

~антитоксический

}

Вакцинацию против туберкулеза проводят: {

~туберкулином

~анатоксином

~антитоксической сывороткой

=бцж

~бруцеллином

}

Факторы вирулентности возбудителей туберкулеза: {

~туберкулин

=кордфактор

~капсула

~жгутики

~экзотоксин

}

Иммунитет при туберкулезе: {

~кратковременный

=нестерильный

~выявляется в реакции Шика

~антивирусный

~антитоксический

}

Микобактериозы вызывают: {

~M.tuberculosis

~M. bovis

=M. kansasii

~M.leprae

~M. Africanum

}

Вакцинацию против туберкулеза проводят: {

~туберкулином

~анатоксином

~антитоксической сывороткой
=БЦЖ
~бруцеллином
}

Для палочки прокавы характерны следующие признаки: {
~наличие зерен волютина
=расположение в мазке в виде «пачки сигар»
~рост на обычных питательных средах
~окраска обычными анилиновыми красителями
~образование спор
}

Микобактерии относятся к бактериям: {
~фототрофным
~анаэробным
=кислотоустойчивым
~литотрофным
~спорогенным
}

Дифтерийный токсин представляет собой: {
~липополисахарид
~липид
~полисахарид
~фосфолипид
=белок
}

Факторы вирулентности дифтерийной палочки: {
~эндотоксин
~жгутики
~капсула
=экзотоксин
~уреаза
}

Коклюшная палочка является: {
=мелкой неподвижной палочкой
~мелкой подвижной палочкой, монотрихом
~мелкой подвижной палочкой, амфитрихом
~мелкой подвижной палочкой, лофотрихом
~мелкой подвижной палочкой, перитрихом
}

Наличие антитоксического иммунитета при дифтерии выявляют с помощью: {

- ~пробы Манту
 - ~пробы Бюрне
 - =пробы Шика
 - ~пробы Дика
 - ~пробы Пирке
- }

Возбудитель дифтерии образует: {

- =экзотоксин
 - ~эндотоксин
 - ~анотоксин
 - ~гиалуронидазу
 - ~ревертазу
- }

Для специфической профилактики коклюша, дифтерии и столбняка применяется: {

- ~вакцина БЦЖ
 - ~вакцина СТИ
 - ~вакцина Смородинцева-Чумакова
 - =АКДС
 - ~вакцина Сэбина
- }

Туберкулезные палочки (таксономическая принадлежность): {

- ~Enterobacteraceae
 - = Mycobacterium
 - ~Micrococcus
 - ~Vibrio
 - ~Spirillaceae
- }

Для туберкулезных палочек характерно: {

- ~ 25% грамположительные
 - ~ 25% кислотоустойчивые
 - ~ 25% неподвижность
 - ~ 25% трудное восприятие анилиновых красителей
 - ~ 100% образование капсулы в организме
- }

Биологические свойства туберкулезной палочки: {

- ~ 33.33333% содержат большое количество железа
- ~ 33.33333%

для роста необходимо повышенная концентрация углекислого газа
~ %50% температурные границы роста 30-38 градусов
~ %50% характерно высокое содержание липидов (восков, фосфатидов)
~%-33.33333% не растут на средах с глицерином
}

Что относится к методу флотации при туберкулезе: {
~ %25%является методом обогащения
~%-100%мазок готовят из осадка
~ %25%добавляют ксилол или бензин
~ %25%готовят мазки из поверхностного сливкообразного слоя
~ %25%встряхивают
}

Для выделения туберкулезных палочек используют: {
~МПА
~Кровяной агар
~Среду Тинсдаля
=Среду Левенштейна-Иенсена
~Желточно-солевой агар
}

Колонии туберкулезной палочки: {
~выпуклые, влажные колонии с ровными краями
~нежные, полупрозрачные блестящие колонии средних размеров
~ колонии мелкие, бесцветные, выпуклые с перламутровым блеском
= морщинистые, суховатые с неровными краями
~круглые, полупрозрачные колонии с зернистой поверхностью
}

Ускоренный МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА: {
~Метод Ермольевой
= Определение корд-фактора
~ Микроскопия в темном поле
~Реакция Асколи
~) РПГА
}

Проба манту может быть поставлена с: {
~Живой вирулентной культурой
~ Вакциной БЦЖ
~ Бруцеллином
~ Милетином
= Туберкулином Коха
}

Проба Манту ставится для: {

= Выявления инфицированных лиц микобактериями туберкулеза

~Лечения туберкулеза

~ Ускоренной диагностики туберкулеза

~ Диагностики туберкулезного процесса

~Профилактики туберкулеза

}

Поражение тканей туберкулезной палочкой связано с: {

= липидами

= туберкулином

~экзотоксином

= корд-фактором

= разрушением митохондрий клеток инфицированного организма

}

Специфическая профилактика туберкулеза: {

~Противопоказания отсутствуют

= Предложена Кальметом и Гереном

~Проводится убитой вакциной

~ Привела к ликвидации туберкулеза

~Создает гуморальную защиту

}

Вакцина БЦЖ: {

~ Состоит из живых бактерий ослабленных при пассировании на животных

= Атенуирована при длительных пассажах на картофельно-глицериновой среде с желчью

~Создает пожизненный иммунитет

~Вводят при вакцинации туберкулезно-позитивным детям

~Вводится внутривенно

}

Специфическая профилактика туберкулеза предложена: {

~Солк-Сэбин

= Кальметом и Гереном

~ Чумаков

~Мечников

~Воробьев

}

Туберкулин: {

~Получают из микробов и токсинов

= Получен из фильтрата бульонной культуры микобактерий

путем обработки химическими веществами, осаждающих белок

- ~Применяется для лечения
 - ~ Состоит из живых бактерий
 - ~Приводит к выработке антитоксического иммунитета
- }

Коринебактерии характеризуются: {

- ~%33.33333%Капсулообразованием
 - ~%50%Расположение в мазке в виде римских цифр V, X
 - ~%33.33333%Грамотрицательной окраской
 - ~%33.33333%Кислотоустойчивостью
 - ~%50%Наличием зерен волютина
- }

Зерна Бабеша-Эрнста выявляются при окраске по методу: {

- ~ Грама
 - ~ Ожешко
 - = Нейссера
 - ~Романовского-Гимзе
 - ~Гисса
- }

К элективным средам для коринебактерий относятся среды: {

- ~%50%Клауберга
 - ~%50%Тинсдаля
 - ~%-100%Вильсон-Блера
 - ~%50% Ру
 - ~%50%Бучина
- }

Рост дифтерийной палочки биовара *gravis* на среде клауберга: {

- = серовато-черные колонии с радиальной исчерченностью
 - ~ круглые, выпуклые колонии
 - ~ прозрачные колонии
 - ~ярко-желтые колонии
 - ~ перламутровые колонии
- }

Цистиназа у коринебактерий определяется: {

- ~В реакции Перке
 - = Пробой Пизу
 - ~В реакции Манту
 - ~ Пробой Закса
 - ~В реакции Хеддельсона
- }

Материалом для бактериологического исследования при дифтерии зева служит: {

~%-33.33333% Спинномозговая жидкость

~%-33.33333% Гной

~%-33.33333% Испражнения

~%50% Слизь из зева, гортани

~%50% Фибринозная пленка

}

Токсигенность коринебактерий определяется: {

~ В реакции агглютинации

~ Иммуноферментным анализом

= Методом Оухтерлони

~РСК

~ В реакции Райта

}

Иммунитет при дифтерии: {

~%-33.33333%Кратковременный

~%50%Антитоксический

~%-33.33333%Нестерильный

~%-33.33333%Естественный пассивный в раннем возрасте

~%50%Выявляется в реакции Шика

}

Для специфической профилактики дифтерии не используют: {

~АКДС

~АДС

=АС

~АД

~АДС-М

}

Для возбудителя коклюша характерно: {

~%25%имеют капсулу

~%25%строгие аэробы

~%25%грамотрицательные

~%25%мелкие коккобактерии

~%-100%палочки средних размеров с закругленными краями

}

Среды для выращивания возбудителей коклюша: {

~%-33.33333%МПА

~%25%Среда Борде-Жангу

- ~%25%КУА
- ~%-33.33333%Среда Леффлера
- ~%-33.33333%Сывороточный агар

}

Специфическая профилактика коклюша осуществляется: {

- ~Антибиотиками
- ~Бактериофагом
- ~Анатоксином
- = АКДС
- ~Живой вакциной из ослабленных возбудителей

}

Слизь из носоглотки при коклюше берут: {

- ~%-33.33333%Петлей
- ~%-33.33333%Трубкой
- ~%50%Методом "кашлевых пластинок"
- ~%-33.33333%Пинцетом
- ~%50%С помощью носоглоточного тампона

}

Какой штамм микобактерий был использован для приготовления вакцины BCG: {

- ~M. avium
- ~M. africanum
- =M. bovis
- ~M. tuberculosis
- ~M. Intracellulare

}

При каком заболевании диагностическое значение имеет обнаружение включений при микроскопии: {

- ~ коклюш
- ~ лепра
- ~ туберкулез
- = дифтерия
- ~ ботулизм

}

По типу дыхания mycobacterium tuberculosis: {

- = облигатный аэроб
- ~облигатный анаэроб
- ~факультативный анаэроб
- ~микроаэрофилл
- ~аэротолерантный анаэроб

}

Свойства *Bordetella pertusis*: {

- = Грамотрицательные мелкие коккобактерии
 - ~ Грамположительные мелкие коккобактерии
 - ~ Грамположительные крупные спорообразующие палочки
 - ~ Грамположительные кокки, расположенные в виде цепочек
 - ~ Грамотрицательные бобовидные диплококки
- }

Bordetella pertusis вызывает: {

- ~ чуму
 - = коклюш
 - ~ гонорею
 - ~ дифтерию
 - ~ скарлатину
- }

Механизм заражения коклюшем: {

- ~ трансплацентарный фекально-оральный
 - ~ фекально-оральный
 - ~ контактный
 - = воздушно-капельный
 - ~ трансмиссивный
- }

Возбудитель коклюша (*Bordetella pertusis*) передается: {

- = воздушно-капельным путем
 - ~ контактно-бытовым путем
 - ~ алиментарным путем
 - ~ через плаценту
 - ~ трансмиссивным путем
- }

Профилактика коклюша проводится: {

- ~ анатоксином
 - ~ живой ослабленной вакциной
 - ~ живой вакциной, входящей в акдс
 - = убитой вакциной, входящей в состав комплексной вакцины акдс
 - ~ специфическим коклюшным бактериофагом
- }

Лабораторная диагностика коклюша: {

- = бактериологическое исследование мокроты больного
- ~ микроскопия клинического материала, окрашенного метиленовой синькой
- ~ постановка кожно-аллергической пробы
- ~ бактериологическое исследование крови и мочи больного
- ~ экспериментальное воспроизведение инфекции

}

Морфологические и тинкториальные свойства *Corinebacterium diphteriae*: {

- ~ грамположительные крупные, ветвящиеся, спорообразующие Палочки
- ~ грамположительные мелкие коккобактерии, образующие капсулу, имеющие жгутики
- = грамположительные палочки, расположенные под углом друг к другу с включениями на полюсах - зернами волютина
- ~ грамположительные кокки, расположенные в виде цепочек
- ~ грамотрицательные бобовидные диплококки, имеют нежную капсулу, неподвижны

}

основной фактор патогенности дифтерийной палочки: {

- ~ нейротоксин
- = гистотоксин
- ~ энтеротоксин
- ~ эндотоксин
- ~ способность предохраняться от фагоцитоза

}

Для выделения *corinebacterium diphteriae* используют среду: {

- ~ 50% Ру
- ~ 33.33333% Мясо-пептонный агар
- ~ 50% Леффлера
- ~ 33.33333% Щелочной агар
- ~ 33.33333% Висмут-сульфит агар

}

Профилактика дифтерии проводится: {

- ~ живой ослабленной вакциной
- ~ убитой цельноклеточной вакциной
- = дифтерийным анатоксином
- ~ антибиотиками
- ~ дифтерийным бактериофагом

}

Неравномерность прокрашивания *C. diphtheriae* анилиновыми красителями обусловлено: {
~спорообразованием
~образованием капсулы
~наличием жгутиков
~ высоким содержанием липидов
= наличием зерен волютина
}

Материалом для бактериологического исследования при дифтерии является:
{
= мазок из зева
~кровь
~ликвор
~фекалии
~ моча
}

Материалом для бактериологического исследования при коклюше являются {
~ фекалии
~кровь
~промывные воды желудка
~ликвор
= носоглоточная слизь, мокрота
}

Бактерии, которые характеризуются кислото-, алкоголь- и щелочеустойчивостью относятся к роду: {
~*Corinebacterium*
= *Mycobacterium*
~ *Bordetella*
~ *Streptococcus*
~*Staphylococcus*
}

Для выявления микобактерий туберкулеза используют микроскопию препарата, окрашенного по методу: {
= Циля-Нильсена
~ Грама
~ Романовского-Гимзе
~Бурри-Гинса
~Ожешко
}

Mycobacterium tuberculosis обладает следующими свойствами:

= тонкие прямые или слегка изогнутые палочки, строгие аэробы, медленно растут
~грамположительные крупные палочки, анаэробы, медленно растут
~ мелкие кокковидные палочки, строгие аэробы, хорошо растут на простых средах
~крупные спорообразующие палочки, факультативные анаэробы, требовательны к средам
~ грамположительные кокки, расположенные в виде виноградных гроздей, не подвижны
}

Специальная среда для культивирования микобактерий туберкулеза: {
~Желточно-солевой агар
~ Щелочной агар
= Среда Левенштейна-Иенсена
~Желчный бульон
~Среда Эндо
}

Кожно-аллергическая проба, выявляющая сенсibilизацию к туберкулезному антигену называется: {
~Пизу
= Манту
~Бюрне
~BCG
~Коха
}

Один из основных факторов патогенности туберкулезной палочки является: {
~Выработка гистотоксина
~Выработка нейротоксина
~Образование гиалуронидазы и плазмокоагулазы
= Токсический гликолипид - корф-фактор
~Наличие жгутиков и пилей
}

Туберкулин применяется для: {
~лечения туберкулеза
~ профилактики туберкулеза
= постановки кожно-аллергической пробы
~ постановки реакции связывания компонента
~постановки реакции агглютинации
}

По типу дыхания *Mycobacterium tuberculosis*: {

= Облигатный аэроб
~ Облигатный анаэроб
~Факультативный анаэроб
~Микроаэрофилл
~Аэротолерантный анаэроб
}

Возбудитель дифтерии содержит: {
=зерна воллютина
~зерна Муха
~тельца Гварниери
~тельца Бабеша - Негри
~зерна крахмала
}

Коринебактерии дифтерии характеризуются: {
~грам(-) окраской
=наличием зерен воллютина
~наличием спор
~кислотоустойчивостью
~капсулообразованием
}

Иммунитет после перенесенной дифтерии: {
~кратковременный
=антитоксический
~нестерильный
~выявляется в реакции дика
~естественный пассивный
}

Биовары возбудителя дифтерии: {
~%-33.33333%classic
~%50%mitis
~%50%intermedius
~%-33.33333%xerosis
~%-33.33333%ulcerans
}

Биовары возбудителя дифтерии: {
~%-33.33333%xerosis
~%50%gravis
~%-33.33333%ovis
~%-33.33333%canis
~%50%mitis

}

Для специфической профилактики коклюша, дифтерии и столбняка применяется: {

~вакцина БЦЖ

~вакцина СТИ

~вакцина Смородинцева-Чумакова

=АКДС

~вакцина Сэбина

}

Для культивирования возбудителя коклюша используют среды: {

=Борде - Жангу

~Эндо

~Левина

~Мюллера

~желчный бульон

}

Для специфической профилактики коклюша применяется: {

~бактериофаг

=вакцина АКДС

~вакцина АДС

~вакцина Эберта - Гайского

~вакцина СТИ

}

Коклюшная палочка является: {

=мелкой неподвижной палочкой

~мелкой подвижной палочкой, монотрихом

~мелкой подвижной палочкой, амфитрихом

~мелкой подвижной палочкой, лофотрихом

~мелкой подвижной палочкой, перитрихом

}

Для специфической профилактики коклюша применяется вакцина: {

~БЦЖ

~Ферми

~Солка

=АКДС

~Сэбина

}

Бактерия туберкулеза названа по имени автора, открывшего возбудителя в 1882 г.: {

- ~ Левенгук;
- ~ Пастер;
- = Кох;
- ~ Геккель;
- ~ Кох

}

Всегда присутствующий симптом при туберкулезе: {

- ~ одышка;
- = кашель;
- ~ кровохарканье;
- ~ повышение температуры;
- ~ насморк

}

Вакцины БЦЖ представляет собой: {

- ~ токсины микобактерий туберкулеза;
- = живые, ослабленные бактерий бычьего вида;
- ~ убитые микобактерий человеческого и бычьего вида;
- ~ живые микобактерий птичьего и мышинного вида;
- ~ ослабленные микобактерии птичьего вида

}

Что не является причиной лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза? {

- ~ короткие курсы лечения;
- ~ монотерапия;
- ~ неправильная комбинация препаратов;
- = несвоевременное лечение;
- ~ длительные курсы лечения

}

Для туберкулезной интоксикации характерна выраженная: {

- = потливость (особенно по ночам);
- ~ снижение трудоспособности;
- ~ чихание частое;
- ~ головные боли;
- ~ насморк

При инфильтративном и цирротическом туберкулезе перкуторно наблюдается: {

- = притупление легочного звука;
- ~ тимпанический звук;
- ~ тихий звук;
- ~ тупой звук;

~ звонкий звук
}

Является перспективным препаратом в лечении туберкулеза у беременных. В первые три месяца беременности не рекомендуются, из-за возможности повышения тонуса матки и угрозы выкидыша: {

~ Изониазид;
~ Стрептомицин;
~ Этамбутол;
= Рифабутин;
~ Тубазид
}

Первичную вакцинацию осуществляют здоровым доношенным новорожденным: {

~ в 1-2 день жизни;
= 1-4 день жизни;
~ 1-6 день жизни;
~ через месяц;
~ через 3 месяца
}

Что является наиболее важным в постановке диагноза туберкулеза у взрослых: {

= исследование мокроты на микобактерии туберкулеза;
~ биохимический анализ крови;
~ проба Манту;
~ общий анализ крови и мочи;
~ проба Бюрне
}

Самая частая форма первичного туберкулеза: {

~ туб интоксикация;
~ инфильтративный туберкулез;
~ первичный туберкулезный комплекс;
= туберкулез внутригрудных лимфатических узлов;
~ туберкулез костей
}

M. tuberculosis открыт: {

~ Л. Пастером
~ А. Кальметом
= Р. Кохом
~ К. Пирке
~ И.И. Мечниковым

}

Возбудители туберкулеза относятся к домену: {

= бактерии

~ грибы

~ растения

~ животные

~ археи

}

Основным возбудителем туберкулеза человека является: {

~ *M. avium*

= *M. tuberculosis*

~ *M. bovis*

~ *M. africanum*

~ *M. microti*

}

Отличительной особенностью микобактерий является: {

~ наличие оформленного ядра

~ проникновение через неповрежденную кожу

= высокое содержание в клеточной стенке липидов

~ образование экзотоксина

~ синтез ферментов патогенности

}

Особенностями микобактерий являются: {

~%50%высокая кислотоустойчивость

~%33.33333%способность к спорообразованию

~%33.33333%способность к синтезу эндотоксинов

~%50%внутриклеточное выживание

~%33.33333%способность синтезировать токсин

}

ОСОБЕННОСТЯМИ МИКОБАКТЕРИЙ ЯВЛЯЮТСЯ: {

~%100%подвижность

~%33.33333%устойчивость во внешней среде

~%30.33333%требовательность к питательным средам

~%30.33333%щелочеустойчивость

~%100%проникновение в организм половым путем

}

Для окраски микобактерий используют метод: {

- ~ Бурри-Гинса
- ~ Романовского-Гимзы
- ~ Нейссера
- = Циля-Нильсена
- ~ Леффлера
- }

Для культивирования микобактерий применяют среды: {

- ~МПА
- ~ МПБ
- ~ Плоскирева
- ~ Эндо
- = Левенштейна-Йенсена
- }

На среде Левенштейна-Йенсена микобактерии туберкулеза образуют колонии в виде: {

- ~битого стекла
- ~ кружевных платочков
- =цветной капусты
- ~маргариток
- ~ромашек
- }

Факторами патогенности микобактерий являются: {

- ~ эндотоксин
- ~экзотоксин
- =липиды
- ~ ЛПС
- ~ плазмокоагулаза
- }

Источником инфекции при туберкулезе являются: {

- ~%33.33333% бактерионосители
- ~%50% больной человек – бактериовыделитель
- ~%50% больное животное
- ~%33.33333% предметы обихода
- ~%33.33333% вода
- }

Пути передачи туберкулеза: {

- ~%33.33333%контактный
- ~%33.33333%воздушно-капельный
- ~%-50%трансмиссивный
- ~%33.33333%алиментарный

~0%-50%половой
}

У человека туберкулезом поражается чаще всего: {
~ желудочно-кишечный тракт
~ мочеполовая система
= органы дыхания
~ органы кроветворения
~ опорно-двигательный аппарат
}

Особенность иммунитета при туберкулезе: {
~ врожденный
~ трансплацентарный
= нестерильный
~ антитоксический
~ стерильный
}

Самым чувствительным методом обнаружения микобактерий туберкулеза в мокроте является: {
~ бактериоскопия с окраской по Цилю-Нильсену
~ люминесцентная микроскопия
~ электронная микроскопия
= посев на среду Левенштейна-Йенсена
~ серологический метод
}

Минимальное количество микобактерий туберкулеза в 1 мл мокроты, выявляемое прямой микроскопией: {
~ не менее 10⁶
= не менее 10⁵
~ 5000-10000
~ 20-100
~ 1-10
}

Минимальное количество микобактерий туберкулеза в 1 мл обогащенной мокроты, выявляемое при микроскопии: {
~ не менее 10⁶
~ не менее 10⁵
= 5000-10000
~ 20-100
~ 1-10
}

Минимальное количество микобактерий туберкулеза в 1 мл обогащенной мокроты, выявляемое при бактериологическом исследовании: {

~ не менее 10⁶

~ не менее 10⁵

~ 5000-10000

=20-100

~ 1-10

}

Результаты бактериологического исследования при диагностике туберкулеза получают: {

~ на 4 день

~ на 7 день

~ через 2 недели

=через месяц

~ через 3-4 месяца

}

Методы специфической профилактики туберкулеза: {

~ экстренная профилактика антибиотиками

=вакцинация

~ введение сыворотки

~ использование иммуноглобулина

~ флюорография

}

Для профилактики туберкулеза используют вакцину: {

~ ТАВТ

~ СТИ

~ Гайского

= БЦЖ

~ ВАН₁₉

}

Вакцина БЦЖ получена: {

~ Пирке

=Кальметтом и Гереном

~ Манту

~ Пастером

~ Кохом

}

Вакцина БЦЖ представляет собой: {

~ инаktivированную вакцину

~ синтетическую вакцину
~ генно-инженерную вакцину
= живую аттенуированную вакцину
~ химическую вакцину
}

Вакцина БЦЖ включает: {
~ инаktivированные клетки
= живые клетки микобактерий бычьего типа
~ живые клетки микобактерий человеческого типа
~ продукты жизнедеятельности микобактерий
~ живые микобактерии птичьего типа
}

Проба Манту используется для: {
~ определения эффективности терапии
= определения необходимости ревакцинации
~ определения чувствительности к антибиотикам
~ идентификации микобактерий
~ определения титра специфических антител
}

PPD содержит: {
~ убитые микобактерии бычьего типа
~ живые микобактерии бычьего типа
= смесь фильтратов убитых нагреванием культур микобактерий человеческого и бычьего типов
~ лиофилизированные микобактерии человеческого типа
~ убитые микобактерии человеческого типа
}

Терапия туберкулеза предусматривает: {
~ 50% проведение кратковременных курсов монотерапии
~ 50% длительное применение одного препарата
~ 33.3333% одновременное применение нескольких препаратов
~ 33.3333% длительное применение нескольких препаратов
~ 33.3333% периодическое определение чувствительности выделяемых культур к Антибиотикам.
}

Заболевание дифтерией вызывает: {
~ *Corynebacterium diphtheriae* нетоксигенный штамм
= *Corynebacterium diphtheriae* токсигенный штамм

- ~*Corynebacterium xerosis*
- ~ *Corynebacterium minutissimum*
- ~ *Mycobacterium bovis*
- }

Решающим для заключения о выделении возбудителя дифтерии является: {

- ~морфология клетки
- ~ ферментативная активность
- = подтверждение токсигенности в реакции преципитации
- ~ проба Пизу
- ~ проба Закса
- }

Определение токсигенности коринебактерии проводится: {

- ~по внешнему виду подозрительных колоний
- ~по биохимическим свойствам
- ~ по результатам пробы Пизу
- = по результатам реакции преципитации в геле
- ~по результатам пробы Закса
- }

Морфологические особенности коринебактерий позволяют: {

- ~установить видовую принадлежность
- = предположить род
- ~ определить биовар
- ~оценить токсигенность
- ~ подтвердить диагноз «дифтерия»
- }

Заключение по результатам бактериологического исследования на дифтерию отрицательное, если выделен: {

- = атоксигенный штамм *C. diphtheriae* биовар *mitis*
- ~ токсигенный штамм *C. diphtheriae* биовар *mitis*
- ~ токсигенный штамм *C. diphtheriae* биовар *gravis*
- ~токсигенный штамм *C. diphtheriae* биовар *intermedius*
- ~токсигенный штамм *C. diphtheriae*

}

Заключение по результатам бактериологического исследования на дифтерию положительное, если выделен: {

- ~ атоксигенный штамм *C. diphtheriae* тип *gravis*
- = токсигенный штамм *C. diphtheriae* тип *mitis*
- ~атоксигенный штамм *C. ulcerans*
- ~ атоксигенный штамм *C. diphtheriae* биовар *mitis*

~ атоксигенный штамм *C. diphtheriae* биовар *intermedius*

}

Температура хранения музейных культур коринебактерий (градусов Цельсия): {

= +4...+10

~-10

~+20...+25

~ -5

~+10...+20

}

Какой тест является решающим в бактериологическом исследовании на дифтерию: {

~ ферментация глюкозы

~расщепление крахмала

= определение токсигенности

~уреазная активность

~кожная проба

}

Обязательными условиями при заборе материала на дифтерию являются: {

~ своевременность взятия материала

~ отдельные тампоны для зева и носа

~ трехкратное исследование

~взятие до начала антибиотикотерапии

= все перечисленное

}

Какой из представителей рода *Corynebacterium* ферментирует цистин: {

~ *C. ulcerans*

= *C. diphtheriae*

~ *C. xerosis*

~ *C. minutissimum*

~ *C. hoffmanii*

}

В отличие от возбудителя дифтерии дифтероиды могут давать положительный тест на: {

~ ферментацию глюкозы

~ цистиназу

= уреазу

~ токсигенность

~ ферментацию крахмала

}

В мазках возбудитель дифтерии имеет вид: {

~коккобактерий

~ биполярных овоидных палочек

=метахроматических полиморфных палочек

~ стрептобацилл

~ изогнутых палочек правильной формы

}

К какой группе по типу дыхания принадлежит возбудитель дифтерии: {

~ облигатный анаэроб

= факультативный анаэроб

~ микроаэрофил

~ облигатный аэроб

~ кислородный фототроф

}

При отсутствии роста колоний на средах первичного посева при подозрении на дифтерию отрицательный ответ выдают через: {

~ 24 ч

~ 48 ч

= 72 ч

~ 12 ч

~ 7 суток

}

Кратность обследования больных с острыми воспалительными явлениями в носоглотке на дифтерию: {

~ однократно

~ двукратно

= трехкратно

~ четырехкратно

~по желанию лечащего врача

}

Контингент лиц, обследуемых на дифтерию: {

~больные с воспалениями носоглотки

~ больные лакунарной ангиной с налётом на миндалинах

~ больные инфекционным мононуклеозом

~больные некротической ангиной

= всё перечисленное

}

Для взятия материала на дифтерию используют: {

- = сухие тампоны
- ~ тампоны, смоченные физ. Раствором
- ~тампоны, смоченные пептонной водой
- ~ шпатель
- ~все перечисленное

}

Забор материала на дифтерию производится: {

- = натошак
- ~ после еды
- ~ через 10 мин после еды
- ~через 30 мин после еды
- ~ независимо от приёма пищи

}

Забор материала при заболевании дифтерией производится: {

- ~из носовых ходов
- ~с миндалин
- ~ с конъюнктивы
- ~ из уха
- = все перечисленное

}

Средой для культивирования коринебактерий дифтерии является: {

- = кровяной теллуритовый агар
- ~ кровяной агар
- ~среда чистовича
- ~ среда эндо
- ~ среда ресселя

}

Для возбудителя дифтерии характерно все, кроме: {

- ~ грамположительные палочки
- ~ располагаются, в основном, под углом
- ~ содержат зерна волютина
- ~ не образуют споры
- = располагаются, в основном, частоколом

}

Метод, являющийся «Золотым стандартом» микробиологической диагностики дифтерии: {

- ~ микроскопический
- ~ биологический
- = бактериологический
- ~серологический

~аллергический

Чашки Петри при сборе материала на коклюш методом
“кашлевых” пластинок удерживаются от больного на расстоянии: {
= 5-10 см
~ 10-15 см
~ 15-20 см
~20-25 см
~ 25-30 см
}

Какая питательная среда применяется для культивирования бордетелл: {
~ кровяной агар
= казеиново-угольный агар
~ желточно-солевой агар
~ кровяной теллуритовый агар
~ молочно-солевой агар
}

Какое заболевание вызывает *Bordetella pertussis*: {
~ паракоклюш
= коклюш
~ тонзиллит
~дифтерия
~ бронхит
}

Морфология возбудителя коклюша: {
~ грамположительные палочки
= грамотрицательные овоидные палочки
~грамотрицательные кокки
~ грамположительные кокки
~ стрептобациллы
}

Какое заболевание вызывает *Bordetella parapertussis*: {
~ ангина
~ коклюш
= паракоклюш
~дифтерия
~ пневмония
}

В микропрепарате клетки коринебактерий располагаются: {

- ~ гроздьями
 - ~ параллельно друг другу
 - = под углом друг к другу
 - ~ цепочками
 - ~ пучками
- }

Дифтерийный токсин блокирует: {

- ~ дыхательный центр
 - = синтез белка в клетке
 - ~ передачу нервных импульсов в синапсах
 - ~ транспорт воды и ионов
 - ~ холинэстеразу
- }

Для коринебактерий дифтерии характерна: {

- ~ продукция экзотоксина всеми штаммами
 - = продукция экзотоксина некоторыми штаммами
 - ~ продукция эндотоксина всеми штаммами
 - ~ продукция эндотоксина некоторыми штаммами
 - ~ продукция экзотоксина и эндотоксина одновременно
- }

Для возбудителя дифтерии не характерно морфологическое свойство: {

- ~ полиморфизм
 - = однородная морфология
 - ~ взаиморасположение под углом друг к другу
 - ~ биполярное окрашивание
 - ~ метакромазия
- }

Возбудитель дифтерии не обладает следующим свойством: {

- ~ биполярное окрашивание
 - ~ метакромазия
 - ~ продукция цистиназы
 - = продукция уреазы
 - ~ продукция экзотоксина
- }

Для дифтерийных палочек характерно наличие: {

- ~ капсул
- ~ спор
- ~ жгутиков
- = зёрен волютина

~ хламидоспор
}

Для определения токсигенности возбудителя дифтерии используется: {

~ РНГА
~ РСК
= реакция преципитации
~ реакция агглютинации
~ реакция гемадсорбции
}

Наиболее часто наблюдается клиническая форма дифтерии: {

~дифтерия носа
= дифтерия зева
~ дифтерия кожи
~ дифтерия раны
~дифтерия половых органов
}

Основной метод окраски микобактерий туберкулеза: {

~ по Граму
= по Цилю-Нильсену
~ по Романовскому-Гимзе
~по Нейссеру
~ фуксином
}

Методы микробиологической диагностики туберкулеза: {

~ бактериоскопический
~бактериологический
~ аллергический
~ генодиагностика (ПЦР)
= все перечисленные
}

Требования к забору материала при диагностике дифтерии (верно все, кроме):

{
= забор одним тампоном из зева и носа
~ доставка в лабораторию не позднее 3-х часов
~ забор двумя тампонами из зева и носа
~ взятие до еды или через 2 часа после еды
~ взятие до начала лечения
}

Достоинства бактериоскопического метода при диагностике туберкулеза

(верно все, кроме): {

~ быстрота

= определение лекарственной устойчивости возбудителя

~ доступность

~ низкая стоимость

~ эпидемиологическая значимость (положительный результат свидетельствует об открытой форме, опасной для окружающих)
}

Определение токсигенных свойств культуры при бактериологическом исследовании на дифтерию проводится: {

= в первые сутки роста подозрительных колоний на чашках первичного посева материала

~ после определения ферментативной активности

~ в зависимости от биовара

~ с помощью реакции агглютинации

~ только при диагностике носительства
}

Особенностями коклюша у детей первого года жизни являются {

~ 25% укорочение инкубационного и катарального периодов

~ 25% отсутствие репризов

~ 50% усиление проявлений интоксикации

~ 25% чаще возникают апноэ

~ 25% чаще возникают осложнения

~ 50% ~ укорочение спазматического периода
}

Назовите методы взятия материала от больного коклюшем для бактериологического исследования: {

~ 50% метод “кашлевых пластинок”

~ 33.3333% двумя сухими заднеглоточными тампонами

~ 33.3333% двумя сухими и одним увлажненным тампонами

~ 33.3333% двумя тампонами, увлажненными забуференным физиологическим раствором

~ 50% двумя заднеглоточными тампонами – сухим и увлажненным.
}

Во время приступа кашля в спазматическом периоде коклюша отмечают: {

~ 50% репризы

~ 50% апноэ

~ 33.3333% токсикоз

~ 33.3333% гипертермия

~ 33.3333% Давление
}

Основные периоды коклюша: {

~%25% катаральный

~%25% инкубационный

~%25% реконвалесценции

~%25% спазматический

~%-100% крупозного кашля

}

Осложнениями коклюша являются: {

~%33.33333% пневмония

~%-50% миокардит

~%33.33333% ателектаз

~%33.33333% субарахноидальное кровоизлияние

~%-50% пиодермия

}

Показателями тяжести коклюша являются: {

~%-50% частая рвота во время приступов кашля

~%33.33333% частота приступов кашля

~%33.33333% апноэ во время кашля

~%33.33333% нейротоксикоз

~%-50% количество репризов во время приступа

}

Особенностями коклюша у детей первого года жизни являются: {

~%25% укорочение инкубационного и катарального периодов

~%25% отсутствие репризов

~%-100% усиление проявлений интоксикации

~%25% чаще возникают апноэ

~%25% чаще возникают осложнения

}